

첫 번째 강의 - 나머지 파트

영상 강의를 보여주는데, 영상과 함께 보시는걸 추천드립니다. 캡처를 하나하나 해오기에는 양이 너무 많아질 것 같습니다.

7. 안면부 망진

① 안면부의 이상 소견 및 특징을 먼저 관찰. 모발이나 피부에서 드러나는 염증, 흉터 등의 특이사항 위주로 관찰.

-> 특이사항이 없는 경우: **이상 소견 없음**으로 표현

진료 기록부에 기재할 때 유의할 것. (정상이라고 표기하지 말기. 이상 소견 없음이라고 표현해야 함)

② 안면부의 대칭 여부파악

- 수평 기준: 미릉골(눈썹쪽) / 눈 / 입술 양 끝 / 양쪽 턱 끝
- 수직 기준: 정중선(인중선)을 따라서 정중선을 긋고 비교

-> 양쪽 광대뼈, 코 기준 좌우측 넓이, 인중선 기준으로 양쪽의 입술 크기, 턱 끝, 하악각을 비교

- 전체적으로 대칭 여부를 먼저 살피고 각 부분의 대칭을 따로 살핀다
- 모두 비대칭이 있다면 비대칭이 가장 심한 부위를 찾는다
- 고정되어 있을 때와 움직일 때 (특히 턱을 움직일때) 비대칭이 있는지 살핀다
- 눈은 바깥쪽 끝부분을 비교하면 됨 (눈 비교가 가장 쉬움)
- 인중선을 기준으로 입의 크기나 길이를 비교
- 턱의 크기나 하악각이 어떤지 확인

- 육안으로 먼저 보고 손으로 만져서 확인해 본다

- 턱을 움직였을 때 비대칭을 확인하기 위해서 크게 아에이오우발음을 시켜서 안면 비대칭 발생 여부를 확인한다 .

8. 안구 검사

① 안구 운동 검사를 먼저 실시 (설압자나 손가락 등을 활용하면 좋음)
- 환자에게 목표를 응시하되 눈동자만 따라서 움직일 것을 지시한다 (어깨 움직임 x)

- 목표물은 환자와 적당한 거리를 유지

- 목표물을 상하좌우로 움직일 때 환자의 눈동자가 따라오는지 확인

-> 이때 목표물은 적당한 속도로 움직이기

-> 좌우 눈동자의 움직임이 같이 발생하는지, 따라오는 속도가 차이가 나는지, 눈동자의 움직임이 불안정한지 정도를 관찰

② 동공 반응 검사 (= 대광 반사) (펜 라이트를 이용)

- 한쪽 눈에 빛을 비췄을 때 양쪽 눈의 동공 반응이 어떤지 살펴보고 반대쪽을 비췄을 때 양쪽 눈의 동공을 살펴본다

-> 실제로 빛은 눈에 4번 비추게 된다

- 펜 라이트를 비출 때 눈 정면에서 다가가면 변화를 알아내기가 어렵기 때문에 옆에서부터 다가가서 비추는 것이 좋다.

- 눈을 떠서 정면을 응시하게 하고 동공을 보면서 동공의 크기가 얼마나 빨리 변하는지 확인

- 왼쪽 눈에 빛을 비추면서 왼쪽 눈뿐만 아니라 오른쪽 눈에 동공 변화도 살피고 반대 방향으로도 시행

- 컨택트 렌즈를 끼거나(빠지거나 다칠 수 있음) 다른 눈 질환이 있는지

확인

- 빛이 너무 밝거나 다른 간접 빛들이 많으면 가린 상태에서 관찰하는 것도 좋은 방법. but 너무 어두운 곳에서는 빛을 안비추는 반대쪽 동공이 잘 안 보이기 때문에 조명 밝기 잘 조절해야 함
- 동공의 수축 속도는 개인마다 다르다.
- > 아주 느리거나 양쪽 눈의 수축 속도가 다르면 문제가 있다고 판단

9. 턱관절 촉진

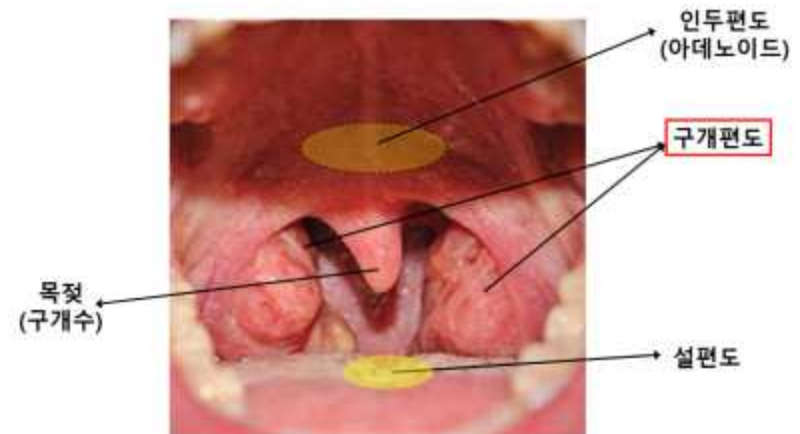
- 이주 아래 방향(외이도 앞쪽 구렛나루 즈음)에 손가락을 위치 (두 손가락으로 하는 것을 추천 / 손이 작은 경우 세 손가락)시킨 후 환자에게 천천히 입을 크게 벌리고 닫게 해서 턱관절을 눈으로 보고 손으로 촉진
- 손 끝에 탄발음 (톡톡, 딱딱), 염발음(짜그락, 짜그락 갈리는 소리)을 확인해 보고 턱관절의 벌어지는 정도가 양쪽의 차이가 심하면 치아의 상태나 저작 습관, 경추의 문제를 의심해 볼 수 있다. 이외에도 너무 안 벌어진다거나 하는 것도 살펴봐야함.
- > 아~ 하게 한 후 다시 입을 다물게 하는 과정을 반복하여 파악

10. 구개 인후부의 관찰 (설진과 겹치는 부분도 있지만 따로 분리해서 확인)

- 설압자와 펜라이트 필요
- 연구개, 경구개, 치아, 혀, 구개편도, 인두편도, 설편도 관찰
- but 설편도는 정상적인 경우에는 잘 관찰되지 않음
- 구개편도의 경우는 개인적인 편차가 있어서 평소에 커져 있는 것이 확인되는 사람도 있음(교수님께서 구글링 해보라 하셔서 구개편도 이미

지는 구글링해서 붙여두겠습니다.)

- 환자의 고개를 약간 들고 입을 벌려 펜라이트를 비춰 구강 내부의 상태와 혀의 위치를 확인
- 설압자로 혀의 1/2 부분을 밑으로 강하게 눌러서 목젖, 뒤의 부분들, 구개편도가 있는지 없는지, 연구개, 경구개, 치아까지 확인
- 혀를 너무 깊이 누르면 구토를 유발할 수 있음
- 혀의 힘이 센 경우가 있어 처음 누를 때 세게 누를 것
- > 누를 때 후하방이 아닌 하방으로 누를 것 (후하방은 구토 유발)
- 목젖 뒤 공간, 목젖과 인후부의 공간도 확인
- > 콧물을 삼키는 동작을 하게 한 후 관찰했을 때 목젖 뒤의 상태가 변화하는 것이 많이 보이면 후비루가 있는 것을 확인할 수 있음
- > 평소 비염이나 다른 호흡기 질환이 있는지를 먼저 확인 후 후비루 상태를 관찰하는 것도 가능



11. 두경부 망진

- 움직이지 않는 상태에서 환자의 몸의 긴장을 풀게 한다
- > 눈을 감고 팔을 늘어뜨린 상태에서 몸을 한번 털어주고 편안한 자세를 취하게 함
- 이 상태에서 눈을 뜨게 하고 머리 위치 확인 (무엇을 응시하게는 X)
- 한 점을 응시하게 하면 머리 위치에 영향을 주므로 주의한다.
- > 그냥 눈을 감았다가 편하게 뜨게 하기
- 정면: 몸의 중심선과 양쪽 어깨 라인을 기준으로 안면부의 수평선과 어깨선이 맞는지를 확인 (어깨선을 눈의 선, 코의 선과 비교하면 쉽게 찾을 수 있음)
- 후면: 척추 라인과 견봉을 이은 선을 확인 (이 2개 말고는 없음. 후면에서 얻을 수 있는 정보는 적다)
어깨선이 후면에서 더 잘보이기 때문에 수평을 찾기는 더 쉬움
- 측면: 귓구멍과 견봉을 이은 선이 수직선과 어떻게 위치관계를 이루는지 확인 (주로 거북목이 많기 때문에 보통 앞쪽으로 기운 경우가 많음)

두경부의 움직임 관찰 (굴곡, 신전, 회전, 측굴)

- 굴곡과 신전은 개인차가 크고 큰 의미 X

① 굴곡과 신전

- 굴곡: 어깨를 움직이지 않은 상태에서 앞으로 숙이는 것
- 신전: 어깨를 움직이지 않은 상태에서 뒤로 젖히는 것
- > 이때 통증이나 확연한 움직임의 제한이 없는 한 큰 문제는 없다 판단

- 통증이 있을 시엔 어디가 아픈건지 체크 필요
- 굴곡, 신전 시에는 어깨가슴이 움직이지 않도록 한다

② 회전

- 회전을 관찰하기 위해서는 회전축을 고정할 필요가 있음
- 어깨를 움직이지 않고 정면 중심축을 기준으로 좌우로 고개를 돌려보게 함
- 시술자가 환자의 턱에 손을 대고 가이드를 해줘야함
- 각도를 재도 좋지만 육안으로 먼저 체크하는 것이 좋음
- 목이 어디까지 돌아가는지를 확인 (반대쪽도)
- 육안으로 회전된 정도의 좌우 차이를 비교할 때 기준점이 필요
- > 턱 끝이 어디까지 움직이는지(어깨와의 관계, 거리) 관찰

③ 측굴 (옆굽힘)

- 환자가 이해하기 어려우므로 시술자가 가이드를 해주면서 관찰해야 함
- 회전을 제한한 상태에서 양측 귓구멍 방향으로 수직으로 움직이게 함
- 양쪽으로 두 번씩 반복
- 통증을 호소하면 통증부위를 확인하고 운동제한이 일어나면 어느 쪽으로 덜 움직이는지 확인

-> 근육의 문제와 결합하여 확인 필요

12. 경향부의 주요 구조물 촉진

- 다른 구조물의 기준이 될 수 있기에 찾는 연습 필요

- 주요 구조물: 갑상연골, 갑상선, 경동맥, 쇄골두, 목정맥 패임, 유양돌기, 후두골, 7번 경추, 1번 흉추

① 갑상연골 (방패연골)

- 방패 모양으로 남성의 경우 더 찾기가 용이
- 삼키는 동작에서 드러남
- > 턱과 목이 만나는 지점에 손가락을 대고 삼키는 동작을 시키면 이때 위쪽 갑상패임을 촉진할 수 있음 , ⇨
- 손가락을 아래로 내려 다시 삼키는 동작을 하게 하면 아래 갑상패임 촉진 가능
- 갑상연골은 이 두 패임 사이에 위치

② 갑상선

- 갑상연골 아래쪽에 나비모양으로 위치
- 일반적인 상태에는 갑상선은 거의 드러나 있지 않고 만져서 촉진하기도 쉽지 않음. 밀도가 매우 낮아 일반 조직과 거의 유사
- 어디 부위에 있다 정도만 확인

③ 경동맥

- 위쪽 갑상패임과 흉쇄유돌근 사이에 존재
- 양쪽을 같이 눌러서 경동맥이 뛰는 것을 확인
- 사람마다 약간씩 위치의 차이가 있음
- 경동맥 뒤쪽에 기관이 있기 때문에 강하게 누르는 등 자극을 주지 않는 것이 좋음 (환자가 불쾌감을 느낌)
- 양쪽이 같이 뛰는 것을 확인

④ 쇄골두

- 쇄골두 = 쇄골이 안에 모이는 부분
- 쇄골두의 위치를 양쪽으로 확인
- 쇄골두의 위치가 수평을 이루는지 확인하려면 jugular notch(목정맥 패임)가 몸 중앙에 있는지 확인함
- > 이때 목정맥패임과 갑상연골의 중심, 턱 아래, 인중선까지 일직선을 이루고 있는지 확인
- 두경부의 위치가 틀어지면 이 일직선이 틀어짐

⑤ 유양돌기, 후두골

- 유양돌기와 후두골 하부라인을 촉진해야 함
- 양쪽 귀 뒤쪽에서 유양돌기의 위치를 확인
- 유양돌기의 양쪽 첩을 두 손으로 잡고 위치가 수평, 수직, 좌우 전후로 양쪽이 맞는지를 확인
- 유양돌기 뒤쪽을 따라서 후두골의 하면을 촉진
- 후두골 하부에는 많은 근육들이 붙기 때문에 긴장도를 느껴보는 게 좋음
- > 이 때 고개를 앞으로 숙이게 되면 긴장을 하게 되므로 뒤로 살짝 굴곡 된 상태에서 촉진하는 것이 편함
- 유양돌기와 하악각 사이에 있는 공간을 만져보고 양쪽의 차이가 어느 정도인지도 확인
- > 이 공간이 좁아지면 사이에 있는 구조물들이 압박을 받아서 다른 문제가 발생할 수 있음

⑥ 7번 경추, 1번 흉추

- 고개를 숙였을 때 목 뒤로 가장 튀어나온 것이 7번 경추인데 1번 흉

추와 붙어 있어서 헛갈릴 수 있으니 주의

- 고개를 회전했을 때 움직이는 것: 7번 경추
- 고개를 회전했을 때 움직이지 않는 것: 1번 흉추

정리) 안면부의 대칭 여부, 턱관절의 움직임, 두경부의 정위, 두경부의 움직임, 목 주위 구조물을 살펴봐야 함.